

कुछ प्रोलैप्स रिपेयर में एक **graft** — अतिरिक्त सहारा सामग्री — उस जगह लगाई जाती है जहाँ आपका अपना ऊतक कमज़ोर है। यह सामग्री **biological graft** या, कुछ विशेष मामलों में, **mesh** हो सकती है। यह पर्चा आपको दोनों विकल्पों की जानकारी देता है — जिसमें transvaginal mesh की सुरक्षा-इतिहास भी शामिल है — ताकि आप अपने सर्जन के साथ मिलकर सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

इस प्रक्रिया के बारे में

योनि में एक चीरा लगाकर कमज़ोर दीवार को ठीक किया जाता है और graft लगाई जाती है ताकि मज़बूती बढ़े और प्रोलैप्स दोबारा होने की संभावना कम हो। सामग्री के विकल्प:

- **Biological graft** — दानकर्ता मानव या पशु ऊतक से बनी; समय के साथ आपका अपना ऊतक इसे अवशोषित कर लेता है।
- **Synthetic mesh** — स्थायी सामग्री, केवल चुनिंदा मामलों में और सावधानीपूर्वक परामर्श के बाद उपयोग की जाती है।

ज़रूरी सुरक्षा जानकारी

प्रोलैप्स के लिए योनि के रास्ते लगाई जाने वाली **synthetic mesh** पर FDA ने चेतावनी जारी की थी और अब इसे अमेरिका में इस उपयोग के लिए बेचा नहीं जाता, क्योंकि इससे mesh का उघड़ना और दर्द जैसी समस्याएँ होती थीं। आज अधिकांश प्रोलैप्स रिपेयर **आपके अपने (native) ऊतक** या biological graft से की जाती है; पेट के रास्ते mesh (जैसे sacrocolpopexy में) एक अलग, सुस्थापित विकल्प है। आपके सर्जन आपको बताएँगे कि कौन सी सामग्री और क्यों उपयोग की जाएगी।

शब्दों को समझें

प्रोलैप्स (Prolapse)

जब पेल्विक अंग नीचे खिसककर उभार या दबाव पैदा करते हैं।

Graft

रिपेयर के दौरान लगाई जाने वाली अतिरिक्त सहारा सामग्री।

Biological graft

ऊतक-आधारित सामग्री जिसे शरीर धीरे-धीरे अवशोषित कर लेता है।

Synthetic mesh

स्थायी सामग्री; transvaginal प्रोलैप्स उपयोग के लिए प्रतिबंधित।

Native-tissue repair

केवल आपके अपने ऊतक से की गई रिपेयर, बिना graft के।

Mesh exposure

जब mesh का एक हिस्सा दिखने या महसूस होने लगे; दर्द या साव हो सकता है।

क्या मुझे mesh से चिंतित होना चाहिए? यह एक उचित सवाल है। जिन समस्याओं के कारण चेतावनियाँ जारी हुईं, वे विशेष रूप से प्रोलैप्स के लिए **transvaginal synthetic mesh** से जुड़ी थीं। Native-tissue रिपेयर, biological grafts, और पेट के रास्ते mesh के अलग-अलग, अच्छी तरह अध्ययन किए गए सुरक्षा-प्रोफाइल हैं। ज़रूरी है कि आप समझें कि आपके सर्जन क्या उपयोग करने की योजना बना रहे हैं और क्यों — अवश्य पूछें।

अपने सर्जन से पूछने के लिए प्रश्न

- आप कौन सी **सामग्री** उपयोग करेंगे — native tissue, biological graft, या synthetic mesh — और मेरे लिए क्यों?
- इसके **विशेष जोखिम** क्या हैं, जैसे mesh का उघड़ना या संभोग में दर्द?
- मेरे **विकल्प** क्या हैं (native-tissue रिपेयर, sacrocolpopexy, पेसरी)?
- प्रत्येक विकल्प में प्रोलैप्स **वापस आने** की कितनी संभावना है?

तैयारी कैसे करें

- **एनेस्थीसिया के निर्देशों** का पालन करें (खाली पेट रहें, बताई गई blood thinners बंद करें)।
- धूम्रपान न करें; घर आने के लिए किसी को साथ लाएँ और मदद का इंतज़ाम करें।
- कई हफ्तों तक हल्का काम और पेल्विक आराम की योजना बनाएँ।

बाद में

- कुछ हफ्तों तक हल्का साव या धब्बे सामान्य हैं।
- **लगभग 6 हफ्तों तक भारी सामान उठाने, ज़ोर लगाने और संभोग से बचें।**
- मल नरम रखें; धीरे-धीरे सामान्य गतिविधि शुरू करें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, ठंड लगना, या अधिक रक्तस्राव
- **पेशाब न हो पाना**, या बढ़ता दर्द
- बाद में: **संभोग में दर्द**, असामान्य साव, या साथी को कुछ महसूस होना (संभावित mesh exposure)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Graft योनि प्रोलैप्स रिपेयर को मज़बूती देती है — biological graft समय के साथ अवशोषित होती है; synthetic mesh स्थायी होती है और चुनिंदा मामलों में उपयोग होती है।
2. प्रोलैप्स के लिए transvaginal mesh पर FDA चेतावनियाँ थीं; native-tissue रिपेयर और biological grafts आम विकल्प हैं, और पेट के रास्ते mesh अलग विकल्प है।
3. पूछें कि कौन सी सामग्री क्यों उपयोग होगी। बाद में संभोग में दर्द या असामान्य साव की सूचना दें।